

Discours - Ambulancier inter-hospitalier

Journées d'études et de formations de l'urgence préhospitalière

MEETT – Parc des Expositions, Centre de Conventions & Congrès de Toulouse

Jérôme Jean-Charles, Laurent BEZIA, Benjamin Cornec

Durée estimée : 20 minutes

Bonjour à toutes et à tous,

Je suis ambulancier inter-hospitalier au CHU de Toulouse, et aujourd'hui, je vais vous parler d'un métier que l'on connaît peu, mais qui est pourtant au cœur de la continuité des soins : le transport sanitaire inter-établissements.

Chaque jour, mes collègues et moi assurons les liaisons entre Purpan, Rangueil, Larrey, l'Oncopole, l'Hôpital des Enfants et les différents sites du CHU. Notre mission est simple à définir, mais complexe à exercer : garantir que chaque patient, quelle que soit sa situation, arrive à destination en sécurité, dans le respect de sa dignité et de ses besoins médicaux.

Mais derrière cette mission se cachent des réalités souvent méconnues.

Des réalités techniques.

Des réalités humaines.

Des réalités psychologiques.

Aujourd'hui, je voudrais vous faire entrer dans notre quotidien à travers trois grands aspects de notre métier :

- la gestion des maladies infectieuses,
- le transport de patients à risque de fugue ou de violence,
- et enfin, un sujet dont on parle très peu : le transport de corps de patients décédés.

1. Les maladies infectieuses : prévenir pour protéger

La première ligne : nos collègues du SAMU

Avant toute chose, je voudrais saluer nos collègues du SAMU, véritables sentinelles sanitaires.

Eux interviennent en première ligne, souvent dans l'urgence, face à des patients dont le statut infectieux est parfois encore inconnu. Une méningite. Une tuberculose. Une gale. Un COVID sévère. Ils ne savent pas toujours ce qu'ils vont trouver avant d'arriver sur place.

Bien sûr, la régulation médicale s'est améliorée. Aujourd'hui, les signes cliniques évocateurs d'infections contagieuses sont mieux identifiés dès l'appel afin de préparer les équipes avant leur départ.

Mais sur le terrain, l'incertitude demeure.

C'est pourquoi les équipes appliquent systématiquement les précautions standards :

- friction hydroalcoolique avant et après chaque contact,

- port de gants,
- masque chirurgical ou FFP2 selon les situations,
- lunettes ou visière si nécessaire,
- adaptation des protections selon les symptômes et les risques biologiques,
- nettoyage et désinfection rigoureux du matériel et du véhicule après chaque intervention.

Ces gestes sont connus de tous ici. Ils font partie des fondamentaux de l'hygiène hospitalière.

Mais lorsqu'il existe une suspicion d'infection hautement transmissible, les mesures montent immédiatement d'un niveau :

- port systématique du FFP2,
- isolement du patient dans l'ambulance lorsque cela est possible,
- information immédiate du service destinataire afin de préparer l'accueil.

Nos collègues du SAMU accomplissent ce travail dans des conditions parfois extrêmement difficiles. Et il est important de le reconnaître.

Nous, ambulanciers inter-hospitaliers : la deuxième ligne

Nous intervenons dans un second temps.

Lorsque nous arrivons dans les services de maladies infectieuses ou dans les unités de soins, les analyses ont souvent été réalisées, le diagnostic est posé ou fortement suspecté. Et cette différence change beaucoup de choses.

Les équipes médicales nous transmettent les précautions à appliquer :

- isolement contact,
- isolement gouttelettes,
- isolement air,
- bactéries multirésistantes,
- tuberculose,
- méningite...

Nous pouvons alors adapter précisément nos pratiques.

Mais notre rôle ne se limite pas au transport.

Nous sommes aussi des acteurs de prévention.

Pendant nos transferts, nous circulons entre les blocs opératoires, les services d'urgences, les soins intensifs, les consultations spécialisées. Nous sommes un maillon mobile entre plusieurs secteurs hospitaliers. Et notre responsabilité est d'éviter que l'ambulance ne devienne un vecteur de transmission.

Pour cela, nous travaillons étroitement avec les infirmiers, les cadres de santé et les référents hygiénistes. Lorsqu'un doute existe sur une procédure ou une protection, nous ne restons jamais seuls face à la décision.

Et puis il y a les patients les plus fragiles : les patients immunodéprimés, les greffés, les patients en aplasie profonde.

Pour eux, le danger vient parfois de l'extérieur.

Dans ces moments-là, nous devenons leur bouclier.

Chaque détail compte :

- environnement maîtrisé,

- matériel désinfecté,
- limitation des contacts,
- respect absolu des protocoles.

Parce que l'ambulance est un lieu de soins à part entière.

Et entre deux établissements, nous sommes le maillon qui protège la continuité de la sécurité sanitaire.

2. Patients à risque de fugue et de violence : des transports sous haute tension

Le deuxième grand défi de notre métier concerne les patients à risque de fugue ou présentant des comportements violents.

C'est une réalité peu visible du grand public, mais extrêmement fréquente dans notre quotidien.

Les détenus pénitentiaires

Nous assurons régulièrement des transports pour les détenus hospitalisés à l'UHSI de Ranguel — l'Unité Hospitalière Sécurisée Interrégionale — ainsi qu'à l'UHSA, dédiée à la psychiatrie pénitentiaire.

Ces patients restent avant tout des patients. Ils ont droit aux soins comme n'importe quel citoyen.

Nous les transportons vers des consultations spécialisées, des examens complémentaires, des blocs opératoires ou parfois vers le tribunal.

Ces missions se déroulent sous escorte : administration pénitentiaire, police, gendarmerie, parfois unités spécialisées.

Il arrive également que nous intervenions auprès de patients particulièrement sensibles, escortés par des unités de sécurité renforcée.

La tension est alors palpable.

Les protocoles sont stricts.

Mais au milieu de cet environnement sécuritaire, il y a toujours une personne malade.

Et notre rôle reste le même : assurer les soins et préserver la dignité humaine.

Les patients psychiatriques

Nous intervenons aussi auprès des patients hospitalisés en secteur psychiatrique fermé.

Accompagnés par les infirmiers du service, nous les transportons vers des consultations somatiques, des examens ou des audiences judiciaires.

Ces transports demandent une vigilance constante.

Le patient peut être angoissé, désorganisé, agité, opposant ou en pleine crise psychique.

Nous devons alors conjuguer :

- sécurité,
- calme,

- fermeté,
- écoute,
- et humanité.

Parce qu'un transport peut devenir un facteur d'apaisement... ou au contraire une source de rupture supplémentaire.

Les adolescents et les personnes âgées vulnérables

Nous prenons également en charge des adolescents souffrant de troubles graves du comportement, notamment depuis les unités spécialisées de psychiatrie de l'adolescent.

Ces jeunes sont souvent en grande souffrance psychique. Le trajet peut devenir un moment extrêmement sensible.

Il peut y avoir des crises, des passages à l'acte, des fugues. Mais parfois aussi, simplement un besoin d'écoute et de présence humaine.

Nous transportons aussi des patients âgés issus des unités Alzheimer ou de gériatrie fermée.

Des patients désorientés, anxieux, parfois agressifs par peur ou incompréhension.

Là encore, notre posture doit rester rassurante et sécurisante.

Les victimes de violences

Enfin, nous assurons le transport de victimes admises aux urgences et nécessitant une prise en charge médico-légale : victimes de violences, agressions sexuelles, viols.

Ces patients arrivent souvent en état de choc.

Le transport doit alors devenir un espace de protection.

Un moment où l'on redonne un peu de calme, un peu de dignité, un peu de contrôle à des personnes qui viennent de vivre une rupture profonde.

Parfois, nous sommes les premiers à leur adresser simplement une parole rassurante.

Et cela compte énormément.

3. Le transport de corps : une mission silencieuse, lourde de sens

Il est un aspect de notre métier dont on parle rarement dans les conférences, dans les formations ou dans les couloirs des hôpitaux.

Et pourtant, il fait pleinement partie de notre quotidien.

Le transport de corps de patients décédés vers la chambre mortuaire.

Chaque semaine.

Parfois chaque jour.

Ce n'est pas une mission secondaire.

C'est une mission à part entière, encadrée par des procédures strictes, physiquement exigeante et profondément éprouvante sur le plan humain.

Des procédures précises que nous devons maîtriser

Lorsqu'un patient décède dans un service, nous intervenons après la réalisation des premiers soins mortuaires par les équipes soignantes :

- identification du corps,
- bracelet d'identité,
- habillage,
- mise en housse biodégradable.

Puis notre mission commence.

La première question que nous devons nous poser est essentielle :

Existe-t-il un Obstacle Médico-Légal ?

Un OML signifie qu'il peut s'agir d'un décès violent, suspect ou inexpliqué.

Et cela change immédiatement toute la procédure.

En cas de doute, nous ne décidons jamais seuls. Nous sollicitons le médecin ou le cadre de santé.

La demande de transport est ensuite saisie sur le logiciel M2Pi, avec une destination précise selon le contexte :

- chambre mortuaire de Rangueil pour les situations médico-judiciaires,
- Purpan ou d'autres sites selon l'établissement concerné.

Lorsque le décès survient à Rangueil, le transport est réalisé par le brancardage pédestre.

Lorsqu'il survient sur un autre site du CHU — Purpan, La Grave, Garonne ou l'Hôpital des Enfants — ce sont les ambulanciers qui assurent le transfert vers la chambre mortuaire de Rangueil.

Mais selon l'heure, les modalités changent encore.

En journée, un agent de la chambre mortuaire accueille le corps et procède à son admission.

En dehors des horaires d'ouverture — la nuit, les week-ends, les jours fériés — nous déposons nous-mêmes le corps dans un casier réfrigéré disponible.

Et c'est là que se pose une question fondamentale : qu'assumons-nous réellement lorsque les agents de la chambre mortuaire sont absents ?

La réponse est simple :

Nous assumons tout.

Nous réceptionnons le corps.

Nous identifions le casier adapté.

Nous installons correctement le corps.

Nous vérifions les documents.

Nous remplissons les informations de dépôt.

Nous glissons les fiches dans les pochettes prévues.

Nous refermons seuls le casier.

Et si le corps provient d'un autre établissement, nous devons également contrôler toute la liasse décès.

Parce qu'une erreur à ce stade peut avoir des conséquences médico-légales graves et irréversibles.

Tout cela se déroule souvent dans une chambre mortuaire vide, en pleine nuit.

Sans agent mortuaire.

Sans cadre de permanence.

Sans présence obligatoire d'un agent de sécurité.

Ce qui signifie que nous sommes seuls.

Seuls avec le corps.

Seuls avec la responsabilité.

Seuls avec ce que cela provoque intérieurement.

Et pourtant, aucune reconnaissance spécifique, aucun accompagnement psychologique systématique, aucune valorisation particulière ne viennent reconnaître cette réalité.

Nous repartons ensuite avec notre ambulance.

Et le prochain appel arrive.

Le risque psychologique : la mort comme collègue de travail

Permettez-moi maintenant d'aborder quelque chose dont on parle très peu.

Nous travaillons avec la mort.

Régulièrement.

Parfois plusieurs fois dans une même journée.

Un patient que nous avons transporté vivant quelques jours auparavant.

Un enfant décédé à l'Hôpital des Enfants.

Une personne dont nous transportons le corps sans avoir eu le temps de réaliser qu'elle était encore en vie peu auparavant.

Nos équipes vivent une exposition répétée au deuil des autres.

Et cette exposition laisse des traces.

On parle aujourd'hui de fatigue compassionnelle.

Certains collègues développent des mécanismes de défense : détachement émotionnel, humour noir, mise à distance.

D'autres rentrent chez eux avec des images qu'ils ne parviennent plus à effacer.

Et puis il y a des situations que seuls ceux qui les ont vécues peuvent réellement comprendre.

Des corps en état de décomposition avancée.

Des décès constatés tardivement.

Des corps qui se vident, qui dégagent des odeurs extrêmement difficiles à supporter, dont la manipulation nécessite des protections renforcées et une résistance psychologique que personne ne nous enseigne réellement.

Ce n'est pas une question de faiblesse.

C'est une réalité physiologique.

Et une réalité professionnelle.

Nous portons des gants renforcés, des masques, des surblouses.

Mais aucun équipement ne protège complètement de ce que ces situations laissent en nous.

L'odeur qui reste longtemps après l'intervention.

La housse hermétique dans l'ambulance.

Le nettoyage et la désinfection du véhicule que nous réalisons ensuite, souvent seuls.

Ces situations représentent aussi un risque biologique réel :

- liquides organiques,
- émanations gazeuses,
- instabilité du corps,
- manutention dangereuse.

Nos protocoles doivent être irréprochables.

Mais psychologiquement, chaque intervention laisse une empreinte.

Et puis il y a une réalité encore plus difficile.

Le décès pédiatrique.

Transporter le corps d'un enfant.

D'un nourrisson.

D'un adolescent que l'on avait peut-être transporté vivant quelques jours auparavant.

Rien ne prépare à cela.

Ni la formation.

Ni l'expérience.

Ni les années de métier.

Un corps d'enfant dans une housse, c'est un poids très léger sur un brancard... et un poids immense sur les épaules.

Ce sont souvent ces transports-là qui reviennent la nuit.

Ce sont ces visages que l'esprit reconstruit malgré nous.

Certains collègues ont demandé à changer de poste après un décès pédiatrique particulièrement éprouvant.

D'autres ont continué en silence.

Parce qu'il n'existe pas aujourd'hui de dispositif systématique d'accompagnement psychologique après ce type d'intervention.

Et pourtant, cela devrait exister.

Parce que ce n'est pas un luxe.

C'est une nécessité humaine.

Et une question de santé au travail.

Les familles et les communautés religieuses : une dimension humaine sous tension

Le transport de corps, ce n'est pas seulement une question logistique.

C'est aussi une rencontre avec des familles en état de choc.

Des proches qui n'acceptent pas encore la perte.

Il arrive que nous croisions des familles dans les couloirs.

Il arrive qu'on nous demande des réponses que nous ne pouvons pas donner.

Il arrive aussi que certaines tensions apparaissent autour :

- des délais,
- des procédures,
- des soins mortuaires,
- des exigences religieuses ou culturelles.

Certaines familles souhaitent accompagner le corps.

D'autres refusent certaines procédures.

Parfois, la douleur se transforme en colère.

Et nous nous retrouvons en première ligne.

Pourtant, nous ne sommes pas formés comme médiateurs.

Mais nous devons malgré tout maintenir le calme, préserver la dignité du défunt et garantir le respect des règles hospitalières et médico-légales.

Et là encore, nous avons besoin :

- de protocoles clairs,
- de soutien,
- de formation,
- et de protection.

La manutention : des corps, des charges, des blessures

Enfin, il faut parler d'un aspect souvent oublié : la manutention des corps.

Un corps adulte représente souvent entre 70 et 100 kilos.

Parfois davantage.

Ce sont des patients qui ne peuvent plus participer aux mouvements.

Des membres rigides ou difficiles à maintenir.

Des chambres encombrées.

Des couloirs étroits.

Des ascenseurs inadaptés.

Des casiers réfrigérés à différentes hauteurs.

Les troubles musculo-squelettiques sont déjà la première cause de maladie professionnelle chez les soignants.

Chez les ambulanciers assurant ces transports, le risque est quotidien :

- lombalgies,
- hernies discales,
- douleurs articulaires,
- atteintes des épaules et des genoux.

Nos corps paient le prix de ces missions.

Et lorsque deux agents doivent manipuler seuls un corps en surpoids dans une chambre saturée de matériel médical, ce n'est plus seulement difficile.

Cela devient dangereux.

La formation aux gestes et postures, les équipements adaptés et des effectifs suffisants ne sont pas des luxes.

Ce sont des mesures concrètes de prévention.

Et ce sont aussi des questions de dignité professionnelle.

Conclusion : un métier complexe, au service de tous

Voilà, en quelques minutes, je vous ai fait entrer dans notre quotidien d'ambulanciers inter-hospitaliers.

Un métier où l'on jongle entre hygiène rigoureuse, sécurité, gestion de crise, manutention lourde, responsabilité médico-légale et accompagnement humain.

Nous ne sommes pas seulement des chauffeurs.

Nous sommes des soignants.

Des acteurs de prévention.

Des professionnels exposés à des situations sanitaires, psychologiques et humaines extrêmement lourdes.

Nous transportons des patients infectieux, immunodéprimés, détenus, psychiatriques, victimes de violences... et parfois des personnes décédées.

Chaque mission exige de nous :

- de la technicité,
- du sang-froid,
- de l'adaptation,
- et profondément, de l'humanité.

C'est pour cela que la formation continue est essentielle.

Parce que nos missions évoluent.

Parce que les protocoles changent.

Parce que chaque patient est unique.

Et parce qu'il est temps que toutes les dimensions de notre métier — y compris les plus silencieuses — soient enfin pleinement reconnues.

Je vous remercie de votre attention.

Je serai maintenant heureux de répondre à vos questions.